

PROBLEMÁTICA

274.000

horas al año digitando formularios a mano en el sistema público

Chile realiza cerca de 1,6 millones de EMPA al año. Cada uno nace en papel y se transcribe a mano al sistema clínico — unos 5 minutos por formulario. La digitación manual introduce errores, retrasa la información clínica y deja los datos archivados sin explotar: la herramienta diseñada para prevenir hipertensión, diabetes y riesgo cardiovascular muere en la transcripción.

1,6 M

EMPA AL AÑO EN CHILE

\$1.700 M

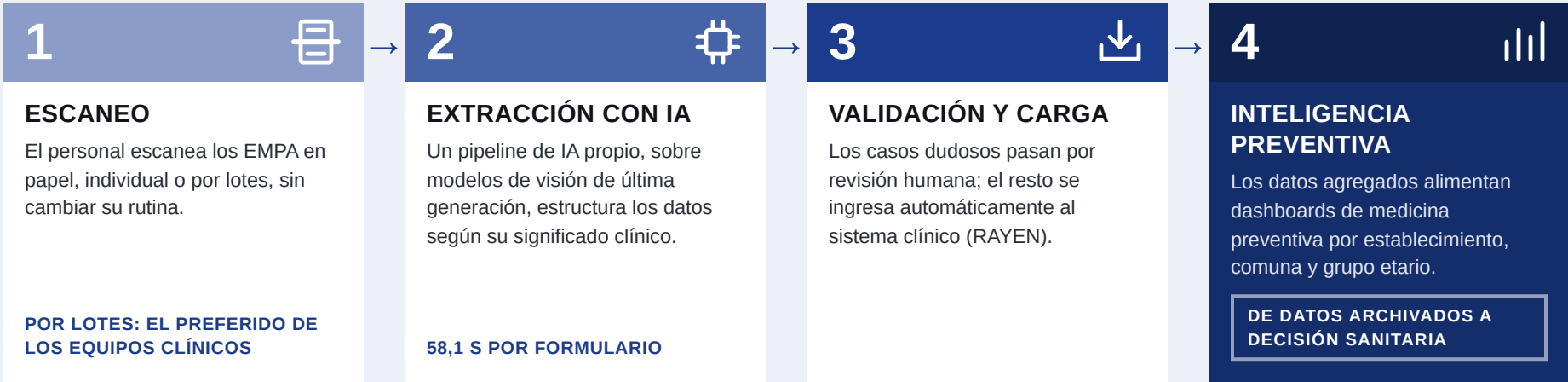
CLP AL AÑO EN TRANSCRIPCIÓN

3,7 vs 9,2

ENFERMERAS POR 1.000 HAB., CHILE VS OCDE

TRABAJO PROPUESTO

UN SOLO FLUJO: DEL PAPEL A LA DECISIÓN



94 % DEL FLUJO SIN INTERVENCIÓN HUMANA · DEMO PÚBLICA: EMPABOT.THRENODY.ME

INTELIGENCIA PREVENTIVA — DATOS REALES

DE DATOS ARCHIVADOS A DECISIONES SANITARIAS

COBERTURA DEL PILOTO

La Serena	Coquimbo	Ovalle
Vicuña	Illapel	Andacollo
Los Vilos	M. Patria	+7 comunas

Piloto activo

Expansión

RIESGO CV DE LA COHORTE, PROYECTADO

Hoy (~21)	+5 años	+15 años	+25 (~46)
1,8 %	2,7 %	5,5 %	12,5 %

CATEGORÍA DE RIESGO A +25 AÑOS

Bajo	55,3 %
Intermedio	25,8 %
Alto	18,9 %

Hoy: 100 % riesgo bajo. Sin intervención, 44,7 % sube de categoría a 25 años.

Datos reales del análisis de cohorte · proyección a 25 años con modelo Framingham, bajo supuesto de hábitos constantes.

RESULTADOS

EVIDENCIA EN TERRENO

PILOTO 2025 — VALIDACIÓN EN TERRENO

Hospital San Pablo de Coquimbo y Consultorio Emilio Schaffhauser: 492 EMPA digitalizados, 92 de operativos reales. De 5 minutos manuales a 58,1 segundos por formulario. Los equipos clínicos prefirieron el escaneo por lotes y valoraron la estratificación automática de riesgo.

SISTEMA 2026 — LA PLATAFORMA DEFINITIVA

Nuevo motor de IA y carga automatizada al sistema clínico: 16 de 17 campos ingresados sin intervención humana y cero escrituras erradas, validado sobre un entorno equivalente a RAYEN.

58 s vs 5 min

POR FORMULARIO

80,6 %

MENOS TIEMPO

5x

MÁS RÁPIDO

0

ERRORES DE ESCRITURA

CONCLUSIONES

LO QUE EL SISTEMA DEMUESTRA

- 1

El circuito completo es viable hoy: escaneo, comprensión clínica, validación humana y carga automática funcionan integrados, con el 94 % del flujo sin intervención y cero escrituras erradas.
- 2

El ahorro es medible y significativo: 5 veces más rápido que la transcripción manual — a escala nacional, 274.000 horas anuales que vuelven a la atención de pacientes.
- 3

La privacidad y la seguridad son diseño, no promesa: el dato personal lo maneja siempre una persona, la duda se escala en vez de adivinarse, y la inteligencia del sistema es propia y auditable.
- 4

El papel archivado se convierte en prevención: los mismos datos que hoy duermen en bodegas permiten estratificar riesgo y anticipar dónde intervenir.

Escalado a nivel nacional, EMPA Vision devolvería 274.000 horas anuales a la atención directa de pacientes y convertiría 1,6 millones de exámenes archivados en inteligencia preventiva para cada centro de salud.